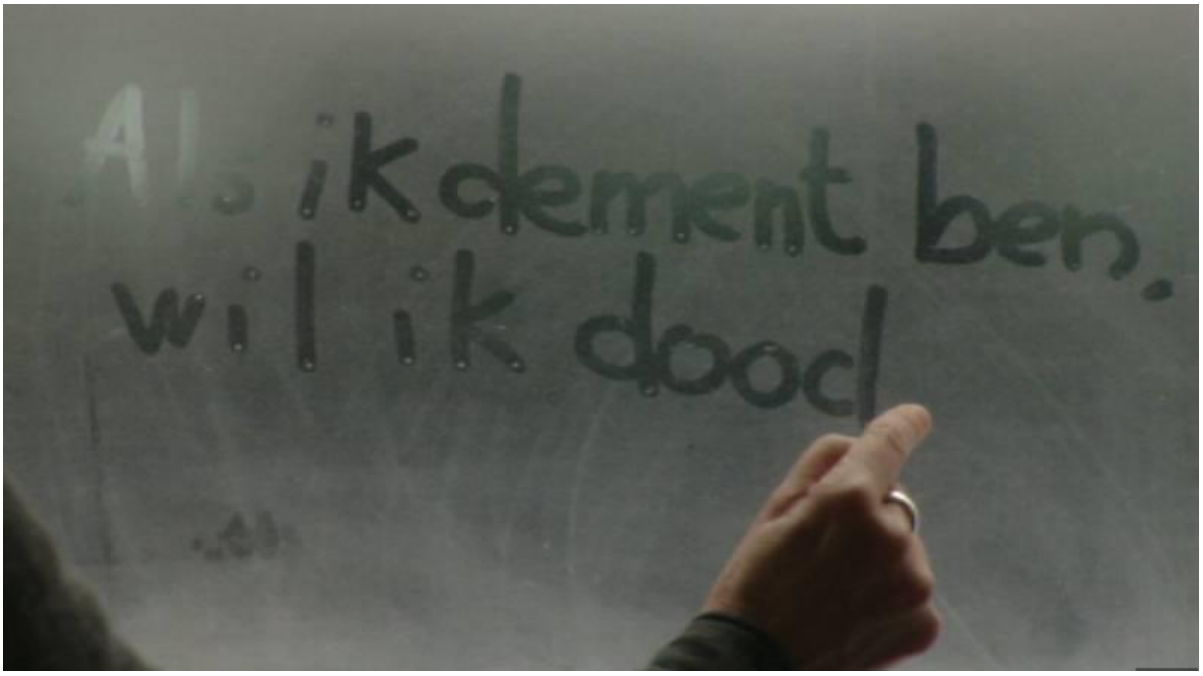
Euthanasie



Het maatschappelijke debat over de ethische toelaatbaarheid van euthanasie en abortus wordt grotendeels bepaald door twee levensbeschouwingen die min of meer tegenover elkaar staan. Het humanistische verlichtingsdenken gaat uit van het primaat van de individuele zelfbeschikking: elke persoon beschikt uiteindelijk zelf over zijn eigen leven en dus ook zijn of haar lichaam en levenseinde; het christelijke (of ruimer, monotheïstische) denken stelt dat het leven ons niet toebehoort maar in handen ligt van God. Het eerste standpunt is pro euthanasie en abortus, het tweede contra.

Sinds 2002 is in België euthanasie wettelijk geregeld. Euthanasie is **alleen wettelijk als de patiënt wilsbekwaam is** en zich bevindt in een medisch **uitzichtloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden, dat niet kan worden verholpen**. De toestand is het gevolg van een ernstige en ongeneeslijke aandoening, veroorzaakt door ziekte of een ongeval.

In 2014 werd een uitbreiding van de euthanasiewet goedgekeurd, waardoor onder strikte voorwaarden ook kinderen recht hebben op euthanasie. Kinderen kunnen geen euthanasie omwille van psychisch lijden krijgen.

Sommigen pleiten voor een bijkomende uitbreiding van de wet, zodat ook demente patiënten, die niet meer wilsbekwaam zijn, recht op euthanasie hebben. Ook gaan er stemmen op die pleiten voor het recht op euthanasie bij zogenaamd voltooid leven, zonder dat er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Nederland, België, Luxemburg, Spanje, Portugal en Oostenrijk zijn binnen de Europese Unie de landen waar euthanasie wettelijk mogelijk is, uiteraard onder specifieke voorwaarden. Ook in enkele staten van de VS is het mogelijk.

Ook het debat over de toelaatbaarheid van abortus wordt bepaald door dezelfde spanning tussen het individuele zelfbeschikkingsrecht en de idee dat het leven ons niet toebehoort.

1. Eerste luik: publieksvragen

Hieronder een aantal stellingen. Zet bij elke stelling een cijfer (1,2 of 3) en licht kort je keuze toe.

1 = Ik ben het er (grotendeels) mee eens

2 = Ik ben het er (grotendeels) niet mee eens

3 = Ik weet het niet, ik twijfel

Stelling 1: "Ik ben blij dat ik in een land woon waarin ik recht heb op euthanasie als ik ooit zou lijden aan een ondraaglijke ziekte die niet te behandelen valt"

Stelling 2: "Ik vindt het terecht dat euthanasie bij dementerende patiënten, die niet meer helder kunnen formuleren wat ze willen, verboden is in België"

Stelling 3: "Ik vind het terecht dat in ons land mensen met langdurige en onbehandelbare depressies recht hebben op euthanasie als ze daar naar vragen"

Stelling 4: "Ik vind het terecht dat Geneviève Lhermitte, de Belgische vrouw die haar vijf kinderen ombracht', na haar gevangenisstraf recht had op euthanasie wegens psychisch lijden"

(lees hiervoor de tekst "Euthanasie voor Geneviève Lhermitte, de vrouw die haar vijf kinderen ombracht" in luik 3)

Stelling 5: "Ik vind dat mensen die op hoge leeftijd oordelen dat hun leven voltooid is, recht hebben op euthanasie, ook al lijden ze niet aan een ernstige ziekte"

Stelling 6: "In ons land kan een vrouw op eenvoudig verzoek een abortus laten uitvoeren tot 12 weken zwangerschap. Ik vind dat correct."

2. Tweede luik: de opbouw van de presentatie

Voor je aan je opdracht begint: herlees de inleidende nota waarin de opdracht wordt toegelicht.

1. Euthanasie

1. Wetgeving

Gebruik deze websites om onderstaande vragen te beantwoorden:

http://leif.be/vragen-antwoorden/euthanasiewet-in-een-notendop/

https://www.gezond.be/euthanasie-belgie/

1.1. Formuleer een nauwkeurige definitie van euthanasie. Lees hiervoor ook de inleiding van dit document (pagina 1).

1.2. Wat zegt de Belgische wetgeving over euthanasie? Onder welke fundamentele voorwaarden is euthanasie toegelaten? (Dit moet ieder van jullie exact kunnen weergeven; het gaat om de Belgische wetgeving)

Gebruik onderstaande tekst die de kern uitmaakt van onze euthanasiewetgeving:

De arts die euthanasie toepast, pleegt geen misdrijf wanneer hij er zich van verzekerd heeft dat de patiënt zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;

Onderstaande vragen moeten hierbij behandeld worden. Antwoord telkens met ja of neen en licht toe:

- Moet een patiënt volgens onze Belgische wetgeving terminaal zijn wil hij recht hebben op euthanasie? Ben je het eens met wat de wet hierover zegt?
- Hebben chronisch depressieve mensen volgens onze wetgeving recht op euthanasie? Ben je het eens met wat de wet hierover zegt? (Lees de teksten "Euthanasie debat laait weer op" en "Belg wil euthanasie omdat hij worstelt met seksualiteit" in derde luik)

  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/08/euthanasie-bij-psychisch-lijden-wanneer-kan-het-hoe-gaat-het-i/
- Kan euthanasie volgens onze wetgeving bij dementerende bejaarden? Akkoord hiermee? (Lees de tekst "Als je niet meer weet dat je wilde sterven")
- Hebben mensen met een ernstige verstandelijke handicap recht op euthanasie? Akkoord?
- Kan euthanasie op premature borelingen volgens de wet? Akkoord?

- Is inspraak van de familie vereist bij een euthanasieaanvraag? Akkoord?

1.3. In 2014 werd de euthanasiewetgeving uitgebreid, zodat ook kinderen in bepaalde gevallen recht op euthanasie hebben. De voorwaarden zijn evenwel een stuk strenger dan bij volwassenen. Waar liggen de verschillen?

http://www.bbc.com/news/world-europe-26181615

http://nieuws.vtm.be/binnenland/207011-kind-krijgt-voor-het-eerst-belgie-euthanasie

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2770056

1.4. Euthanasie-expert Wim Distelmans over de psychologische impact van de wetgeving op patiënten: https://www.youtube.com/watch?v=aaEsN9vXSBU

2. De uitvoering van euthanasie

2.1. Hoe verloopt een euthanasie-uitvoering?

2.2. Soms loopt de uitvoering van een euthanasie niet zoals gepland.

- Lees de tekst 'Euthanasie door verstikking met kussen: parket van Luik opent onderzoek' in luik 3
- Een ander voorbeeld was de euthanasie uitgevoerd bij Tine Nys. Het controversiële euthanasieproces rond deze euthanasie in 2020 heeft geleid tot achterdocht bij artsen, die nu minder bereid zijn euthanasie uit te voeren uit angst voor fouten en veroordelingen. Leg dit uit.

2.3. De voorbije jaren zijn enkele opmerkelijke euthanasiedossiers in het nieuws gekomen. Meestal gaat het dan om euthanasie omwille van psychisch lijden en de bijzondere context waarin die plaatsvond. Geef enkele voorbeelden.

Lees hiervoor de teksten in luik 3:

- "De euthanasie van terreurslachtoffer Shanti De Corte: 'Op Instagram schreef ze dat ze dood wilde. Als moeder is dat vreselijk om te lezen'" in luik 3.
- "Zes jaar nadat moeder van Wout (25) verkracht werd, mag ze euthanasie plegen: 'In dit verhaal is er maar één schuldige'"
- 'Euthanasie voor Geneviève Lhermitte, de vrouw die haar vijf kinderen ombracht'

2.4. De vraag is ook wat de psychische impact is op artsen die euthanasie uitvoeren. Lees hiervoor de getuigenis in luik 3: "Arts over euthanasie: 'Ik moest 5 à 6 keer prikken. Terwijl je weet dat de patiënt een pijnloze dood verwachtte'"

3. Cijfers

3.1. Er is een forse stijging van het aantal euthanasieaanvragen. Heb je cijfers? Kun je die stijging verklaren? Welke evolutie is er op het vlak van geweigerde euthanasieaanvragen?

Lees hiervoor ook de tekst in luik 3: Bijna 3.000 mensen kozen voor euthanasie vorig jaar: "Euthanasiewet is steeds bekender"

3.2. Welke evolutie is er op het vlak van euthanasieaanvragen op grond van 'ondraaglijk psychisch lijden'?

3.3. Je hoeft geen Belg of inwoner van België te zijn om beroep te doen op onze euthanasiewetgeving. Is er sprake van 'euthanasietoerisme' in ons land? Cijfers?

Lees ook de tekst in luik 3: "150 buitenlanders kregen euthanasie in België: "Het mag geen toerisme worden"

3.4. België en Nederland zijn de grote voorlopers van het recht op euthanasie wereldwijd. Maar hoe zit het met de rest van Europa en de rest van de wereld? Zijn er nog landen waar euthanasie legaal is? Maak gebruik van een overzichtskaartje. Hoe zit het met landen als Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Duitsland, Oostenrijk en de VS bv? Zoek hiervoor de meest actuele informatie.

4. Ethische kwesties

Lees de artikels in luik 3. Mogelijk vind je hier voorbeelden die je in je presentatie kan gebruiken.

4.1. Niet iedereen is gelukkig met onze euthanasiewet. Vanuit katholieke middens is er verzet. "Tegenwoordig ligt er te veel nadruk op de individuele autonomie van de patiënt. Dat staat haaks op hoe mensen leven: in verbondenheid met anderen", zegt medisch ethicus Chris Gastmans (KU Leuven). Daarom pleit hij er in zijn boek 'Kwetsbare Waardigheid' voor dat patiënten hun familie en zorgverleners meer bij zware beslissingen zoals het verzoek om euthanasie zouden betrekken.

Ben je het eens? Vind je dat de wetgeving in ons land te weinig rekening houdt met de familie, die in principe niet gehoord moet worden wanneer een patiënt euthanasie wil?

De website https://www.euthanasiestop.be/?lng=nl voert campagne tegen de euthanasiewetgeving in ons land. Het initiatief wordt gedragen door katholieken, moslims, artsen enz. Benoit Beuselinck is een van de gangmakers van de beweging.

Formuleer minstens drie argumenten op basis waarvan dit platform ageert tegen de wetgeving en de manier waarop die wordt uitgevoerd. Zijn er argumenten die je kunnen overtuigen?

Wat is het standpunt van de Katholieke Kerk over euthanasie? Hoe zit het met andere religies?

4.2. De laatste tijd wordt er in België ook gepleit voor een dubbele uitbreiding van het recht op euthanasie. Schets deze problematieken. Raadpleeg hiervoor het derde luik. Wat vind je er zelf van? Gaat een dergelijke uitbreiding van de wetgeving te ver? Dreigen we met deze uitbreidingen op een hellend vlak terecht te komen, waarbij mensen steeds makkelijker euthanasie kunnen verkrijgen?

- Een *eerste uitbreiding* betreft het recht op *euthanasie bij dementie*. Momenteel is dit niet mogelijk in ons land, omdat je op het moment van de euthanasie wilsbekwaam moet zijn. In Nederland kan het onder bepaalde voorwaarden wel. Maar er lijkt in ons land stilaan politieke bereidheid om euthanasie toe te laten voor mensen die wilsonbekwaam zijn geworden als ze daar eerder expliciet om gevraagd hebben.
https://www.youtube.com/watch?v=C2l91YsodMg&t=1280s

https://leif.be/petitie-euthanasie-bij-dementie/

- Een *tweede uitbreiding* betreft het recht op euthanasie bij een *voltooid leven*. Momenteel is dit onmogelijk in België en een dergelijke wetsuitbreiding lijkt er niet meteen te komen.

De inmiddels overleden voormalige radiopresentatrice Lutgart Simoens hield een sterk pleidooi voor het recht op euthanasie bij een voltooid leven.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/27/lutgart-simoens-pleit-voor-euthanasie-bij-een-voltooid-leven/

https://leif.be/data/press-articles/Knack.be_-_Lutgart_Simoens_pleit_voor_euthanasie_bij_voltooid_leven__Ik_wil_rustig_sterven._Zonder_zorgen_zonder_pijn_27-08-19.pdf

Een fragment uit een interview met Lutgart Simoens:

> ‘Waarom moet ik eerst ondraaglijk lijden? Is het niet genoeg dat ik moet leven met het verlies van al die mensen die ik heb liefgehad? Mijn kleindochtertje, twee van mijn kinderen, mijn broers en mijn zus, mijn eerste man, mijn partner. Waarom mag ik niet sterven vóór ik fysiek begin af te zien? Laat tachtigplussers zelf beslissen. Als zij vinden dat hun leven voltooid is, respecteer dat dan.’

Toon deze tekst. Wat vind je hiervan?

Lees de tekst “Over euthanasie, voltooid leven en de bemoeizucht van directies” in luik 3.

4.3. Soms willen gehuwden samen euthanasie plegen. Is dit mogelijk in ons land?

http://www.standaard.be/cnt/dmf20161023_02533655

4.4. Kunnen patiënten die euthanasie wensen hun organen doneren?

Lees hiervoor het artikel in luik 3: 'Wat hij wilde op de dag van de euthanasie, was nog nooit eerder gedaan': een huisarts over de patiënt die zijn pad veranderde.

4.5. Een interessante problematiek betreft de vraag of gedetineerden die een levenslange gevangenisstraf moeten uitzitten en zwaar depressief zijn, het recht op euthanasie kunnen claimen.

Leg de problematiek rond Frank Van den Bleeken hierbij uit. Raadpleeg https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/27/geens-over-van-den-bleeken/ Wat vind je er zelf van? Is er hier sprake van doodstraf op aanvraag?



http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1756244

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3823279/2015/01/05/Doodstraf-op-aanvraag-levert-Belgie-felle-kritiek-op.dhtml

4.6. In de Japanse fictiefilm '*Plan 75'* biedt de Japanse overheid senioren gratis aan euthanasie te laten uitvoeren. Op die manier moet het probleem van de extreme vergrijzing van het land worden opgelost.

https://www.cinenews.be/nl/films/plan-75/videos/14040/

5. Palliatieve sedatie, zelfmoord en assisted suicide

5.1. Wat is palliatieve sedatie en wat zijn de verschillen met euthanasie? Dreigt palliatieve sedatie een verdoken vorm van euthanasie te worden?

5.2. Verwant met de problematiek van euthanasie is die van de zelfmoord. In België proberen dagelijks zeventig mensen een einde aan hun leven te maken. Ongeveer 10% van deze pogingen lukt. Zelfdoding is de eerste doodsoorzaak bij mannen tussen 25 en 45 jaar, en de tweede bij jongeren tussen 15 en 25 jaar.

Kan je deze cijfers verklaren?

5.3. Naast zelfmoord en euthanasie bestaat er ook iets als '*assisted suicide'*. Wat is het? Waar is het toegelaten? Zie je ethische bezwaren?

https://www.statista.com/chart/28133/assisted-dying-world-map/

https://www.bbc.com/news/technology-59577162

Toon volgend nogal verbijsterend fragment:

https://watchpeopledie.tv/h/suicide/post/23496/michle-causse-assisted-suicide-scene-from/894807#context

https://www.youtube.com/watch?v=jFdbcWr9gVA

(zoektermen: michle causse/assisted suicide)

5.4. De Australiër Philip Nitschke is de oprichter van *Exit International*, een organisatie die pleit voor het recht van mensen om hun leven zelfstandig en op vreedzame wijze te beëindigen. https://www.youtube.com/watch?v=LdQkWbDLuqI

6. Nog enkele videolinks waaruit je eventueel een fragment kunt laten zien.

https://www.youtube.com/watch?v=IXWMIokE10Y&t=169s

https://www.youtube.com/watch?v=TyEPId-irdU&t=376s

https://www.thisistheend.nl/kijkonline

2. Abortus

Abortus is het vroegtijdig afbreken van een zwangerschap door medisch ingrijpen.

In ons land is abortus volgens de huidige wetgeving niet strafbaar tot 12 weken zwangerschap.

Vandaag kan een abortus alleen in een erkend centrum - er zijn er zeven in Vlaanderen - of ziekenhuis plaatsvinden. Er gaat een psychosociaal gesprek en een medisch onderzoek aan vooraf. Daarna geldt een verplichte wachttijd van zes dagen.

Er zijn twee methodes. Tot zeven weken kan een medicamenteuze abortus. Dan wordt via medicatie een miskraam uitgelokt. Na die periode vindt een zuigcurettage plaats, waarbij de baarmoeder met een smal buisje wordt leeggezogen.

Voorbij de twaalfde zwangerschapsweek tot aan de geboorte, is abortus wel strafbaar, tenzij de zwangerschap een "ernstig gevaar" inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of indien vaststaat dat het kind zal lijden aan een zeer ernstige en ongeneeslijke kwaal.

Waarom pleiten sommige politieke partijen voor een versoepeling van de wet en willen ze de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, optrekken van 12 naar 18 weken zwangerschap? Waarom willen ze ook de verplichte bedenktijd grondig inperken?

In Nederland is abortus toegestaan tot het moment waarop de foetus levensvatbaar is buiten het moederlichaam (24 weken). Gevolg is dat veel zwangere vrouwen uit andere landen met een strengere wetgeving (ook uit België) naar Nederland komen voor een abortus.

https://www.youtube.com/watch?v=VI6E6bPZ6eo

In de Verenigde Staten werd in 2022 het federale recht op abortus afgevoerd en mogen sindsdien alle Amerikaanse staten zelf hun abortuswetgeving bepalen. In de praktijk betekent dat dat veel (republikeinse) staten abortus verbieden of zullen verbieden.

https://www.youtube.com/watch?v=l3-H93w63dU

Het politieke en ethische debat over de toelaatbaarheid van abortus wordt gedomineerd door twee kampen: het 'pro-life'-kamp en het 'pro-choise'-kamp. Voor het 'pro-life'-kamp is abortus moord, een euthanasie op wilsonbekwaam, ongewenst ongeboren leven. De "pro-choice"-kant van het debat plaatst het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw centraal. Een zwangere vrouw is 'baas in eigen buik'.

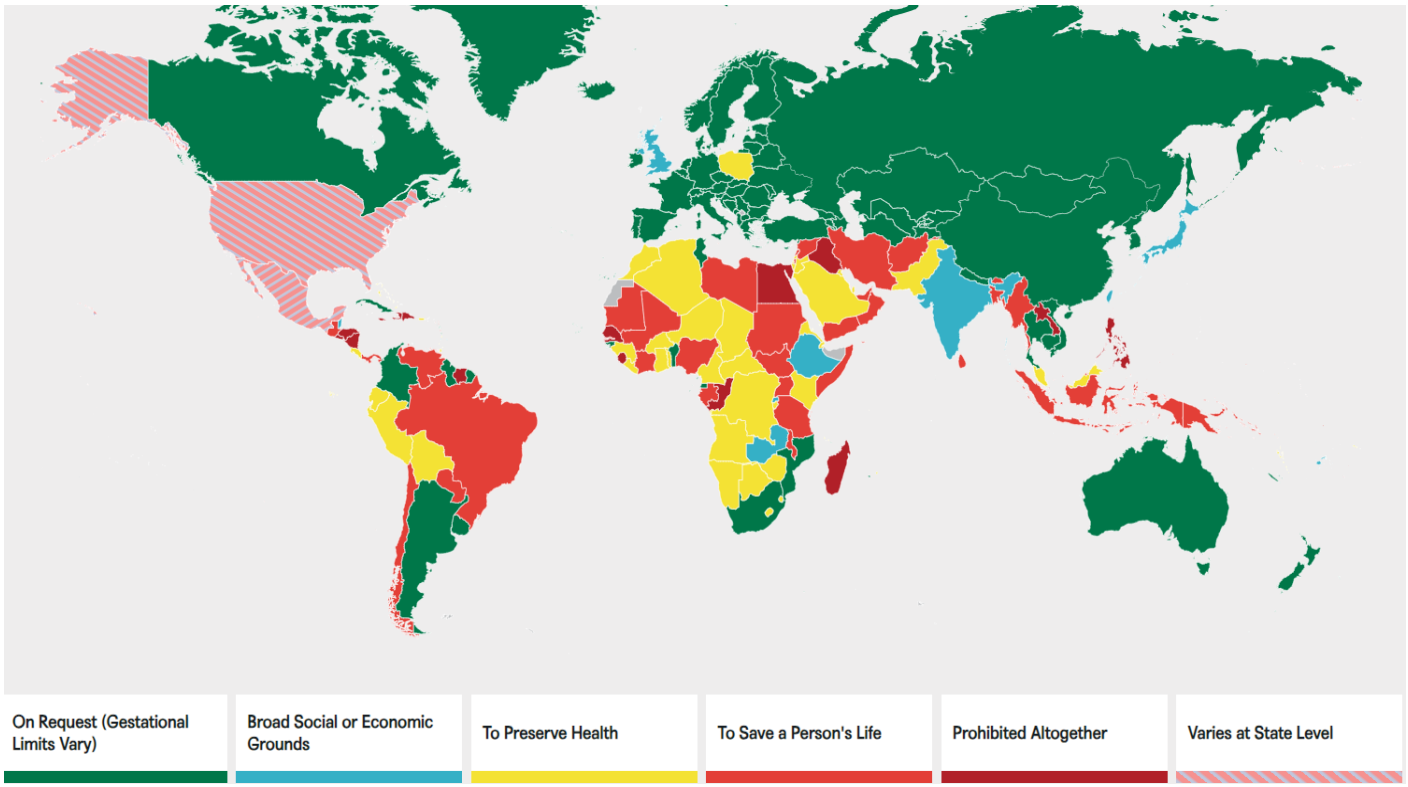
Fundamenteel in het debat is de vraag vanaf wanneer het ongeboren leven een bewustzijn ontwikkelt, een vermogen om bv. pijn of angst te ervaren. Doe wat opzoekwerk.

Tegenwoordig staan bijna alle Europese landen abortus toe op eenvoudig verzoek van de zwangere vrouw, tenminste in het eerste trimester van de zwangerschap, en bijna alle Europese landen zorgen er ook voor dat abortus tijdens de zwangerschap legaal is wanneer dat nodig is om de gezondheid of het leven van een zwangere persoon te beschermen.

Christendom en islam staan eerder negatief tegenover het recht op abortus. Binnen het monotheïsme is individuele zelfbeschikking zoals bekend van ondergeschikt belang. God beslist over leven en dood, niet de mens. Toch zijn er verschillen tussen het officiële Rooms-katholieke standpunt en het islamitische standpunt. Volgens het Rooms-katholieke standpunt is het menselijk leven heilig en dat leven begint al vanaf de conceptie. Abortus is daarom altijd ontoelaatbaar, ook in de prilste fase van de zwangerschap. Binnen de islam kan abortus wel worden toegestaan voor de 120ste dag zwangerschap, omdat de ziel pas vanaf dan pas in het ongeboren leven afdaalt.

https://www.kn.nl/nieuws/paus-abortus-is-nooit-het-antwoord/

Presenteer de hieronder staande worldmap in verband met abortus:



Bron: https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/ (toon eventueel de interactieve kaart via de link)

3. Derde luik: teksten

Fragment uit Belgische euthanasiewet

Art. 3.
§ 1. De arts die euthanasie toepast, pleegt geen misdrijf wanneer hij er zich van verzekerd heeft dat:
- de patiënt een meerderjarige of een ontvoogde minderjarige is die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek;
- het verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is, en niet tot stand gekomen is als gevolg van enige externe druk;
- *de patiënt zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening*;

Nederland breidt euthanasie uit naar min-12-jarigen

April 2023

In Nederland wordt het voor kinderen jonger dan 12 jaar mogelijk om een vorm van euthanasie te krijgen, besliste de Nederlandse regering. Enkel kinderen die 'ondraaglijk' en 'uitzichtloos' lijden, kunnen aanspraak maken op de behandeling. In ons land bestaat die mogelijkheid al sinds 2014.

Minister van Volksgezondihed Ernst Kuipers verduideljkt: "Enkel een kleine groep van ongeneeslijk zieke kinderen, die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en bij wie de mogelijkheden van palliatieve zorg niet volstaan om hun lijden te verlichten, komt in aanmerking."

De behandelend arts moet er op grond van heersend medisch inzicht van overtuigd zijn dat levensbeëindiging “het enige redelijke alternatief is om het uitzichtloos en ondraaglijk lijden van het kind weg te nemen”, zegt de minister verder nog.

Tot nu toe focuste de euthanasiewet vooral op 'volwassenen' die hun leven wilden beëindigen. Daarbij kunnen mensen die ouder zijn dan twaalf aanspraak maken op de behandeling, op voorwaarde dat ze lijden aan een medische aandoening zonder uitzicht op verbetering. Bovendien moet een tweede, onafhankelijke arts geraadpleegd worden om de diagnose te bevestigen.

Een lacune bleven de kinderen tussen 1 en 12 jaar, want voor baby's jonger dan 1 jaar is alles al wettelijk vastgelegd in het zogenaamde 'Groningenprotocol': daar gelden strene voorwaarden als men - in overleg met de ouders - een dodelijke dosis medicijnen zou toedienen om een einde te maken aan uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Nu wordt de laatste lacune dus opgevuld en kunnen deze kinderen eveneens in aanmerking komen voor euthanasie. Het gaat om een kleine groep kinderen, naar schatting vijf tot tien kinderen per jaar, die ongeneeslijk ziek zijn en bij wie de mogelijkheden van palliatieve zorg ontoereikend zijn om het lijden te verlichten.

Artsen in Nederland waren al langer vragende partij voor een wetswijziging.

Bron: **https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/nederland-breidt-euthanasie-uit-naar-min-12-jarigen.html**

Euthanasie door verstikking met kussen: parket van Luik opent onderzoek

Het parket van Luik is een gerechtelijk onderzoek gestart tegen een dokter en twee verpleegsters voor de dood van een terminale patiënte in maart 2022. Ze zou zijn verstikt met een kussen.

REDACTIE 6 september 2023 DeMorgen

Volgens de kranten Le Soir en La Meuse werd de terminaal zieke vrouw verstikt met een kussen nadat het medisch team haar had verdoofd. De advocaten van de verschillende partijen bevestigen dat er een onderzoek loopt.

De 35-jarige dame leed sinds eind 2021 aan een ongeneeslijke kanker, en na een ziekenhuisbehandeling werd ze thuis verder medisch opgevolgd. In maart 2022 was haar situatie zodanig verslechterd dat ze hulp vroeg om te sterven. Maar volgens de kranten verliep de procedure slecht voorbereid en rommelig, en werd uiteindelijk een kussen gebruikt om de vrouw te doden. Uit de autopsie bleek dat er sporen waren van verstikking, aldus La Meuse en Le Soir.

De partner en dochter van de vrouw stelden zich burgerlijke partij. Zij waren zelf niet in de kamer aanwezig, maar getuigen wel over een vreemde situatie. Er was veel commotie en ze zouden de patiënt hebben horen schreeuwen.

Het parket van Luik wilde woensdag geen commentaar kwijt.

Euthanasie

Arts over euthanasie: ‘Ik moest 5 à 6 keer prikken. Terwijl je weet dat de patiënt een pijnloze dood verwachtte’

LEIFarts Patrick Wyffels is opgeleid om huisdokters te assisteren bij euthanasie. Beeld ID/ Joren De Weerdt

In Luik werd een ongeneeslijk zieke vrouw (36) verstikt met een kussen nadat een arts en twee verpleegkundigen eerder vergeefs hadden geprobeerd om haar te euthanaseren. Verloopt een euthanasie wel vaker niet zoals het hoort? Raken dokters soms in paniek? ‘Een euthanasie uitvoeren is ook voor een arts een enorm stresserende bedoening’, zegt dokter Patrick Wyffels.

LIEVE VAN BASTELAERE 7 september 2023, DeMorgen

Patrick Wyffels (71) is gepensioneerd huisarts maar nog steeds actief als LEIFarts. LEIFartsen zijn dokters die speciaal zijn opgeleid om huisdokters te assisteren bij euthanasie. “De eerste keer euthanasie uitvoeren is een geweldig grote stap. Vandaar dat de meeste huisartsen de eerste of tweede keer vragen aan een LEIFarts om erbij te zijn”, weet hij. “Het is niet evident om rustig en zonder stress naar de woning van een patiënt te rijden om daar een euthanasie te gaan uitvoeren. Euthanasie is ook voor de dokter zelf enorm stresserend, ook al is het - technisch gezien - niet moeilijk.”

Blijf op de hoogte

Krijg een melding bij belangrijke artikelen over In het nieuws.

EEN PIJNLOZE DOOD

“De eerste keren dat je euthanasie uitvoert, heb je toch altijd een beetje schrik dat het niet zal lukken. Daardoor kan je hand minder vast worden als je een ader zoekt”, zegt dokter Wyffels. “Bij fel vermagerde mensen is het sowieso niet evident om een geschikte ader te vinden. Ik heb het zelf al meegemaakt dat ik begon te spuiten en dat de ader plots kapotsprong. Ik moest vijf à zes keer prikken. Dat gaf behoorlijk wat stress. Je weet dat de patiënt een pijnloze dood verwachtte. En bovendien stond de familie daarop te kijken.”



Alexina Wattiez, de Luikse vrouw die verstikt werd met een kussen, en haar dochtertje. Beeld Sudpresse

In paniek is dokter Wyffels naar eigen zeggen nooit geraakt, maar hij kan zich wel voorstellen dát het gebeurt. Hij oppert dat het medisch team in Luik misschien in paniek is geraakt toen bleek dat de medicatie om de 36-jarige vrouw te euthanaseren niet het gewenste effect had. “In die zin kan ik wel

begrip opbrengen voor wat er achteraf is gebeurd, waarmee ik uiteraard niet gezegd heb dat het oké is wat ze gedaan hebben, want dat is zeker niet het geval", stelt hij.

"Maar soms kan het inderdaad lang duren voor een patiënt overlijdt. Ik heb het zelf meegemaakt dat er geen hartslag meer was en dat ik al bezig was met het invullen van de papieren toen de patiënt plots weer begon te ademen. Dan moet je rustig blijven en weten wat je moet doen. Bijkomend probleem is dat de medicatie waarmee we euthanasie uitvoeren, niet altijd even vlot verkrijgbaar is. Barbituraten bijvoorbeeld worden veel gebruikt, maar moeten we nu aankopen in het buitenland. Ofwel moeten we werken met medicatie die we minder goed kennen, wat ook weer niet ideaal is."

Wyffels benadrukt dat een arts die euthanasie uitvoert, meestal alleen is. Er is geen medisch team dat assisteert, behalve dan als het gebeurt in een woon-zorgcentrum of een ziekenhuis. Meestal bevindt de dokter zich in een kamer bij de patiënt thuis, vaak samen met de familie. Het is de patiënt zelf die mag beslissen waar de euthanasie wordt uitgevoerd en wie erbij mag zijn. "Meestal verloopt dat allemaal goed, maar soms zijn er verre familieleden die zich weren als duivels in een wijwatervat. Of een kind dat enorm veel druk gaat uitoefenen op zijn ouder om de euthanasie toch niet te laten doorgaan. Ik begrijp dat wel, we gaan dan ook met hen in dialoog. Maar uiteindelijk is het altijd de patiënt zelf die het laatste woord heeft."

Daarmee is niet gezegd dat het allemaal kommer en kwel is, integendeel zelfs. "Elke euthanasie is uitzonderlijk. Het is steeds weer een heel individueel gebeuren, maar wat me vaak bijblijft, is hoe enorm dankbaar patiënt én familie kunnen zijn. Ik heb ooit euthanasie uitgevoerd bij een vrouw met jongdementie. Haar oude moeder, ex-partner, partner en drie kinderen met hun partners waren allemaal aanwezig. Ik ben daar buiten gestapt met het gevoel dat ik iets goeds had gedaan. Iemand lijdt ondraaglijk en daar heb je een einde aan gemaakt."

POËZIE VOORDRAGEN

"Het gaat er echt om dat je iets goed doet. Je bent op dat moment een heel belangrijke persoon voor die mensen, maar zodra je binnen bent, maak je jezelf klein. Dan vraag je om je te laten weten wanneer zij er klaar voor zijn. Er zijn patiënten die willen dat de euthanasie onmiddellijk gebeurt. Anderen vragen wat meer tijd. Ik heb eens een halve dag bij een dichter gezeten die graag nog poëzie wou voordragen. Dat was heel bijzonder. Voor zulke wensen moet je als arts ook tijd maken. De meeste LEIFartsen kunnen dat, omdat ze dikwijls al gepensioneerd zijn, net als ik."

Wyffels is intussen twintig jaar LEIFarts, wat betekent dat hij al heel wat ervaring heeft opgedaan met euthanasie. Maar de meeste dokters in ons land hebben er géén ervaring mee. Vorig jaar werd in België 3.000 keer euthanasie uitgevoerd, terwijl er hier iets meer dan 47.000 artsen zijn. "Je bent minder zenuwachtig omdat je de techniciteit beheerst en weet wat je moet doen", zegt hij. "Omdat je ervaring hebt opgebouwd, ben je wat rustiger. Maar dat wil niet zeggen dat het uitvoeren van euthanasie went. Ik heb me altijd voorgenomen: ik wil niet dat het went."

Interview 'Die ene patiënt'

'Wat hij wilde op de dag van de euthanasie, was nog nooit eerder gedaan': een huisarts over de patiënt die zijn pad veranderde

Artsen en verpleegkundigen vertellen over de patiënten die hun leven veranderden. Deze week: huisarts Han Mulder.

ELLEN DE VISSER 10 juni 2023, DeMorgen

"Peter was een hardwerkende jonge vent, trots op het schildersbedrijf dat hij had opgezet. Zo'n patiënt die ik nooit op het spreekuur zag, totdat hij steeds meer vage klachten kreeg: spierpijn en vermoeidheid. Na een lange ronde langs specialisten werd in 2014 een fatale diagnose gesteld: hij had ALS. Onmiddellijk daarna kwam hij langs om te vertellen wat hij voor ogen had met de rest van zijn leven. Hij

wilde euthanasie als hij het gevoel had zijn autonomie te verliezen én hij wilde dan ook zijn organen doneren.

“Het leek me een vanzelfsprekend verzoek. Aanvankelijk was ik alleen bezig met de euthanasie, ik wilde weten hoe hij zijn laatste fase voor zich zag, waar hij de grens zou trekken. Pas daarna ging ik informeren naar het tweede deel van zijn vraag en toen bleek opeens dat ik me op die vanzelfsprekendheid had verkeken. Orgaandonatie na euthanasie was zeer ongebruikelijk, het was wereldwijd hooguit vijfentwintig keer gedaan. Peter zei: ik wil nog iets goeds doen met dit zieke lichaam dat me zo teleurstelt. Het was zo’n aannemelijke, mooie, logische wens, maar ik liep tegen muren op.

“Euthanasie en orgaandonatie zijn twee gevoelige procedures, en hier moesten ze ook nog eens worden samengevoegd. En toen trof ik in het lokale ziekenhuis een intensivist die meteen zei: dat moet kunnen. Samen zijn we op pad gegaan om het voor Peter te regelen. Dat kostte veel tijd en veel overredingskracht, ook omdat er nog iets bij kwam: Peter wilde thuis inslapen. Hij wilde in zijn eigen huis afscheid nemen van zijn familie, in slaap worden gebracht, dan naar het ziekenhuis om zijn organen te doneren en meteen terug zodat hij in zijn kamer kon worden opgebaard. Dat was nooit eerder gedaan. Het lastige was dat hij daarvoor thuis onder narcose moest worden gebracht en gehouden. Daarvoor moest de intensivist het ziekenhuis uit, een zeer ongebruikelijke stap. We wisten bestuurders en collega-artsen ervan te overtuigen hoe belangrijk dat was.

“Het is gegaan zoals Peter graag wilde. Drie jaar na de diagnose was hij bijna volledig verlamd en brak het moment aan waarop hij niet verder wilde. Op een mooie zonnige aprildag ben ik naar hem toe gegaan. Hij zat in de tuin, nam de slaapmedicatie in, werd geholpen bij het drinken van zijn laatste glas wijn en zakte weg in de armen van zijn moeder. Om de hoek van zijn huis stond, uit het zicht, een ambulance klaar, met de intensivist aan boord. Samen hebben we hem naar het ziekenhuis gebracht waar de orgaandonatie plaatsvond. ’s Avonds bracht de begrafenisondernemer hem weer naar huis.

“Wat ik zo indrukwekkend vond aan Peter was de diep ervaren dubbelheid van zijn bestaan. In zijn dromen was hij vogelvrij zoals nog maar kort daarvoor, maar zodra hij zijn ogen opende zat hij gevangen in een ziek en onwillig lijf. Dat gevoel heb ik daarna bij meer ALS-patiënten herkend.

“Dankzij Peter is er nu een landelijke regeling (in Nederland; ook in België is dit in bepaalde omstandigheden mogelijk, red.). Door hem ben ik lid geworden van een commissie die een richtlijn heeft opgesteld voor orgaandonatie na euthanasie. Dat heeft twee jaar gekost, we hebben met tal van partijen om de tafel gezeten, tientallen gesprekken gevoerd. Een maand voordat Peter overleed was de eerste versie af. Ik ben ermee bij hem langsgegaan, hij vond het fantastisch. Ik zei hem: dit is jouw werk geweest. Nu weet ik hoe groot de stimulans van één enkele patiënt kan zijn en ook hoeveel je als arts voor zo’n patiënt kunt bereiken. Al moet je er muren voor afbreken.”

Bijna 3.000 mensen kozen voor euthanasie vorig jaar: "Euthanasiewet is steeds bekender"

Februari 2023

Zo'n 3.000 mensen hebben vorig jaar in ons land euthanasie gekregen. Dat is een stijging van bijna 10 procent. Dat meldt de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. "Er is meer bekendheid over de euthanasiewet bij de bevolking", zegt oncoloog Wim Distelmans.

Laurens Dekock

Die stijging ligt in de lijn van de vorige jaren, zegt professor palliatieve zorg Wim Distelmans. "Er is een toename van geregistreerde euthanasiegevallen. Dat komt omdat er meer bekendheid is over de euthanasiewet bij de bevolking, vermoeden we."

Het zijn vooral mensen met ongeneeslijke kanker die kiezen voor euthanasie. De meerderheid leed zowel lichamelijk als psychisch. Euthanasieverzoeken van patiënten met een cognitieve stoornis, zoals

dementie, of een psychiatrische aandoening, blijven uitzonderlijk. Daar spelen de voorwaarden vermoedelijk een rol. Mensen met dementie mogen bijvoorbeeld niet meer voor euthanasie kiezen als hun ziekte verder gevorderd is.

Er is ook een groot verschil in leeftijd. Bijna 70 procent van de patiënten waren ouder dan 70. Euthanasie onder de 40 jaar blijft zeer beperkt (1,2 procent). Minderjarige patiënten die voor euthanasie kozen, waren er niet. Het laatste geval dateert van 2019.

Al sinds het begin van de euthanasiewet uit 2002 zijn er in verhouding meer Nederlandstalige dan Franstalige patiënten die voor euthanasie kozen. Dat verschil wordt steeds kleiner. "Vorig jaar was de verhouding 70 procent Nederlandstaligen tegenover 30 procent Franstaligen", zegt Distelmans. "In het begin was die verhouding 80-20."

Hoewel het totaal aantal Nederlandstalige patiënten dat voor euthanasie kiest dus wel stijgt, lijkt die stijging plots trager te gaan dan bij Franstalige patiënten.

Volgens Distelmans zou dat te maken kunnen hebben met het assisenproces van Tine Nys begin 2020. De vrouw van 38 kreeg in 2010 euthanasie vanwege "uitzichtloos psychisch lijden", maar volgens de familie werd de euthanasiewet niet correct nageleefd. Drie artsen die erbij betrokken waren, moesten daarom voor de rechter verschijnen.

Dat proces veroorzaakte heel wat ophef in Vlaanderen en veel minder in het Franstalige landsdeel. "Enkele Vlaamse artsen twijfelen sindsdien om euthanasie uit te voeren. Uit bevraging blijkt dat die twijfelende artsen hun patiënten doorverwijzen naar andere artsen. "

Er komen ook steeds meer mensen uit de buurlanden (vooral Frankrijk) om hier euthanasie uit te voeren, ziet Distelmans. Het gaat in totaal om 61 geregistreerde gevallen.

"De Belgische euthanasiewet vereist niet dat iemand Belg moet zijn. Steeds meer buitenlanders hebben dat begrepen en komen via het internet naar België. Dat dit gebeurt, wijst erop dat die landen beter ook een euthanasiewet kunnen stemmen zodat hun inwoners niet naar België moeten afzakken."

Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/02/17/cijfers-euthanasie-2022/

Macron wil van regering wetsvoorstel over euthanasie

April 2023

De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat de regering nog "tegen het einde van de zomer" met een wetsvoorstel komt rond het levenseinde. Dat zei hij bij het ontvangen van de conclusies van een burgerconferentie, die zich recent uitsprak voor "actieve hulp bij het sterven".

Aan die actieve hulp zouden wel voorwaarden verbonden zijn. Zo mag die nooit worden uitgevoerd om een sociale reden en Macron deed ook de deur dicht voor elke hulp bij het sterven voor minderjarigen.

De burgerconferentie debatteerde de voorbije drie maanden op vraag van de Franse regering over de huidige Franse wetgeving rond het levenseinde. De overgrote meerderheid, 84 procent, vindt dat het huidige kader niet volstaat en pleit ervoor om een mogelijkheid te voorzien om "actieve hulp" te bieden bij het sterven.

In Frankrijk is actieve euthanasie, of het toedienen van een dodelijk middel aan iemand, verboden. Passieve euthanasie, bijvoorbeeld door het uitschakelen van machines, of indirecte euthanasie, waarbij sterke medicatie de pijn verlicht en het sterven versnelt, zijn wel toegestaan.

De euthanasiewetgeving beroert al jaren de gemoederen in Frankrijk. Nu steken Fransen vaak de grens over naar EU-landen met een liberalere wetgeving, zoals Nederland of België, op zoek naar hulp.

Bron: https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/macron-wil-van-regering-wetsvoorstel-over-euthanasie.html

Belg wil euthanasie omdat hij worstelt met seksualiteit

2016

Een 39-jarige landgenoot wil euthanasie omdat hij zijn seksuele geaardheid niet kan aanvaarden. In het BBC-programma 'Victoria Derbyshire' zei de man dat hij euthanasie wil vanwege 'ondraaglijk psychisch lijden'.

De man, die anoniem getuigt, zegt dat hij al zeventien jaar behandeld wordt. Hij ziet naar eigen zeggen geen andere optie. De man zegt dat hij zich aangetrokken voelt tot jonge mannen en jongens in hun adolescentie. Hij zegt ook dat hij getekend is door een moeilijke kindertijd: zijn moeder was ziek en godsdienst was allesoverheersend. 'Toen ik opgroeide, ontmoette ik een jongen en ik werd smoorverliefd. We waren allebei vijftien. En het was gewoon ondraaglijk. Ik wou niet homo zijn', zegt de man in het programma.

De BBC wijst er op dat euthanasie in België niet zo vanzelfsprekend is. Patiënten moeten bijvoorbeeld aantonen dat hun aandoening ongeneeslijk is. De BBC citeert professor Gilles Genicot van de Universiteit van Luik, Franstalig voorzitter van de euthanasiecommissie in ons land, die meent dat de zaak van de man niet voldoet aan de wettelijke criteria. 'Het lijkt er eerder op dat hij psychologische problemen heeft die gerelateerd zijn aan zijn geaardheid. Ik zie hier geen spoor van een psychische ziekte.' Hij sluit euthanasie evenwel niet uit als elke behandeling gefaald heeft, en drie artsen concluderen dat er geen andere optie meer is.

Het verzoek tot euthanasie zou alvast initieel aanvaard zijn, schrijft de BBC op haar website. Er moet nu verder onderzocht worden of hij aan de wettelijke criteria voldoet. De man lijkt in elk geval vastbesloten: hij geeft zelf aan nog weinig hoop te hebben op een 'mirakeloplossing'.

© De Standaard, 2016

150 buitenlanders kregen euthanasie in België: "Het mag geen toerisme worden"

Een 23-jarige Youtubester uit Frankrijk krijgt geen euthanasie in ons land. Maar met haar aanvraag staat ze niet alleen. De voorbije zes jaar kregen zowat 150 buitenlanders hier wél euthanasie. Het aantal gunstige aanvragen verdrievoudigde op drie jaar tijd. "Het mag geen toerisme worden."

Koen Baumers

26 januari 2023

Ik ben geestelijk uitgeput, vertelt Olympe (23) op haar sociale media. Ze deelt er het verhaal van een jarenlange strijd met mentale problemen en met trauma's uit haar jeugd. Nadat ze het verhaal hoorde van Shanti (23) uit Kontich, die vorig jaar euthanasie kreeg, probeert ze zelf ook in aanmerking te komen voor euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. Ze klopte aan bij een arts in Brussel, omdat het in Frankrijk niet is toegelaten. Maar dat draaide op niets uit.



Ze zou nochtans lang niet de enige Franse burger zijn geweest die in ons land euthanasie krijgt. In 2020 en 2021 kregen in ons land minstens 79 mensen euthanasie nadat ze speciaal daarvoor naar ons land waren gekomen. Dat zijn er meer dan drie per week. Dat blijkt uit de cijfers van de Euthasiecommissie, die elke twee jaar verslag uitbrengt aan de parlementen.

Het zijn er wellicht méér dan dat, want de woonplaats van patiënten staan in het confidentiële deel van de officiële formulieren. En dus heeft zelfs de Euthanasiecommissie er geen toegang toe. Alleen als de artsen het expliciet vermelden op de andere papieren, tellen ze mee. In 2016-2017 waren het er 23, in 2018-2019 gebeurde dat 45 keer en in 2020-2021 dus 79 keer. Een klein aantal in vergelijking met de 2.500 binnenlandse dossiers per jaar, maar wel een verdrievoudiging op drie jaar tijd.

"Het fenomeen komt steeds vaker voor, want via internet vinden mensen sneller de weg", zegt Wim Distelmans, als professor palliatieve geneeskunde (VUB) en lid van de Euthanasiecommissie een fervent voorvechter van het recht op een waardig levenseinde. "Buitenlanders hebben vaker door dat je geen Belg moet zijn om hier in aanmerking te komen. Ook bij ULteam, waarmee we mensen begeleiden die elders uit de boot vallen maar wel aan de wettelijke voorwaarden voldoen, krijgen we geregeld aanvragen vanuit het buitenland."

De tendens wekte enkele jaren geleden nog de bezorgdheid van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. "Op zeker ogenblik was er een Franse organisatie die een kamer huurde in een tehuis om daar patiënten te laten opnemen", zegt voorzitter Paul Cosyns. "Daar hadden we onze bedenkingen bij. We waren tegen zo'n geïnstitutionaliseerde vorm van wat bijna toerisme is. Maar als ze in ons land opgenomen worden en hun situatie beantwoordt aan de regels van de Belgische euthanasiewet, dan kan het eigenlijk wel."

Distelmans wil het dan ook niet over toerisme hebben. "Toen abortus bij ons nog niet in de wet stond, was er sprake van abortustoerisme naar Nederland. Maar dan gaat het om jonge, gezonde vrouwen. Bij euthanasie zijn het mensen die zwaar ziek zijn. Het is een grote stap om dan naar een ander land te gaan. We hebben al Amerikanen gehad die naar België wilden komen, maar ingehaald werden door de omstandigheden."

Voor mensen als influencer Olympe, die euthanasie aanvragen wegens psychisch lijden, is er weinig kans op een gunstig advies. "Het lijkt me moeilijk of niet mogelijk", zegt Cosyns. "Er moet een Belgische arts advies geven en bij psychiatrische indicaties betekent dat toch dat je ze goed moet kennen en opvolgen over een langere periode."

De buitenlanders die in België euthanasie kregen, leden dan ook stuk voor stuk aan een lichamelijke aandoening, waarbij de uitzichtloosheid snel duidelijk was. Het ging zonder uitzondering om 50-plussers met een ernstige neurologische ziekte zoals MS of ALS, of een uitgezaaide kanker.

"Het is schrijnend dat mensen op het einde van hun leven nog zo'n inspanning moeten doen om op een waardige manier hun levenseinde in te vullen", zegt Distelmans. "Het betekent vooral dat die landen verdorie zelf eens werk moeten maken van dergelijke wetgeving."

Bron: BvL - 26 januari 2023

Over euthanasie, voltooid leven en de bemoeizucht van directies

30 januari 2023



Wie om euthanasie vraagt in een woonzorgcentrum of ziekenhuis, botst nog geregeld op weerstand, ook na twintig jaar euthanasiewet. De Orde van Artsen stelt nochtans dat directies geen rol spelen bij een euthanasievraag en zich er niet tegen kunnen verzetten. Daarnaast blijft het begrip 'voltooid leven' discussies oproepen. Getuigenissen van drie huisartsen.

De Standaard brengt getuigenissen van Leif-artsen Frank Heyvaert en Gerlinde Wijns over de bemoeizucht van buitenaf. Maar ook De Correspondent liet de Rotterdamse huisarts Michelle Van Tongerloo ruim drie jaar geleden al getuigen over een spanningsveld dat zeer gelijkaardig is in Nederland, vooral dan als het gaat over het begrip 'voltooid leven'.

De Antwerpse huisarts Frank Heyvaert vindt het schokkend dat bij een gevalsbespreking over een euthanasie-aanvraag van een 90-jarige bewoonster uit het WZC, de directie in 2021 mee aan tafel zat. "De euthanasiewet schrijft overleg met het verplegend team voor, maar de directeur maakt daarvan geen deel uit. Ook niet als hij of zij zelf arts of verpleegkundige is."

Ook de Orde van Artsen was hierover formeel. Ze oordeelde in maart 2022 dat artsen de directie van een zorginstelling niet mogen inlichten over een euthanasieverzoek van een bewoner of patiënt, noch over het verloop ervan. Directies hebben geen rol te spelen bij een vraag om euthanasie en kunnen zich niet tegen de uitvoering verzetten, aldus het advies. De arts moet zich immers houden aan zijn beroepsgeheim bij elke medische tussenkomst.

Dokter Heyvaert schenkt klare wijn: "De tijd dat directies met brede armen de deur versperden, is voorbij. Maar nogal wat directies en artsen geven liever een pilletje tegen depressie dan echt te luisteren naar wat bewoners of patiënten zeggen. Het gaat zeker niet alleen om katholieke instellingen, dit paternalisme is nog breed verspreid."

Over een gelijkaardige casus getuigt in De Standaard eveneens Gerlinde Wijns, huisarts en Leif-arts in Antwerpen. Zij diende een klacht in bij het ethisch comité van een ziekenhuis, dat zogezegd 'een algemeen verbod op euthanasie' hanteerde. De euthanasievraag van een 90-jarige vrouw aan de huisarts werd er gecounterd door een assistente in opleiding die toch drie artsen inschakelde om zogenaamd een en ander uit te klaren. Een cardioloog en een psychiater gingen op de rem staan, waarna de huisarts zich terugtrok.

Met enig uitstel kreeg de patiënte uiteindelijk toch thuis euthanasie nadat dr. Wijns en een andere huisarts haar verhaal beluisterd hadden. 'Boven op het lijden van patiënten wordt extra lijden gelegd, door de onkundigheid van artsen', luidt het verdict van dr. Wijns. Overigens leidde dat geval tot een positieve evolutie: het ziekenhuis besliste na klacht van dr. Wijns om alle artsen en verpleeg- en zorgkundigen de kans te bieden zich bij te scholen in kwesties rond het levenseinde.

De casus van dr. Heyvaert leverde eveneens een positief effect op, vermits de directie zich later niet meer bemoeide met het geval. Dokter Heyvaert neemt het Orde-advies nu wel mee naar andere woonzorgcentra: “Sommige directies argumenteren dat zij de plicht hebben om zorgzaam te zijn - alsof ingaan op een euthanasievraag niet zorgzaam zou zijn.”

Tegelijk verduidelijkt Frank Heyvaert wel dat levensmoeheid op zich geen grond is voor euthanasie. Het komt erop aan om als arts de tijd te nemen om naar de vraag te luisteren en zich empathisch en begripvol op te stellen zodat dit onderscheid kan worden gemaakt.

Dat doet sterk denken aan de ervaringen van de Rotterdamse huisarts Michelle Van Tongerloo. Drie jaar geleden al verwoordde ze de knelpunten verhelderend in *De Correspondent*, onder de naam: “Ik ben huisarts en worstel met de dood op bestelling.” Haar standpunten zijn vandaag nog razend actueel.

Ze heeft het over het feit dat patiënten euthanasie als een gewone medische handeling zijn gaan zien. Of dat ze terughoudender is geworden nadat het openbaar ministerie besloot om vier euthanasiezaken te onderzoeken. “Zeggen dat je ‘klaar’ bent met leven is soms een noodkreet. Bewust of onbewust misschien zelfs een beetje manipulatief”, schrijft ze. Ze behandelt de existentiële kwestie die rijst bij de vraag wanneer een leven voltooid is. En ze geeft toe: “Voor goede palliatieve zorg heb ik te weinig tijd.”

Waarmee we weer zijn aanbeland bij de boodschap van dokter Heyvaert dat je als arts voldoende tijd moet nemen om naar dergelijke vragen te luisteren. Zelfs al heb je die tijd niet. Voordeel is gelukkig dat je als huisarts je patiënten kent en dus met enige voorsprong start om de oorzaak van bepaalde klachten en uitingen beter herkennen.

Bron: https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/over-euthanasie-voltooid-leven-en-de-bemoeizucht-van-directies.html

Euthanasie voor Geneviève Lhermitte, de vrouw die haar vijf kinderen ombracht

Maart 2023

Geneviève Lhermitte, de vrouw die in 2007 haar vijf kinderen om het leven bracht, heeft dinsdag euthanasie laten uitvoeren. Dat gebeurde dag op dag 16 jaar na de gruwelijke feiten, schrijven verschillende media op basis van informatie van Sudinfo.

In december 2008 werd Lhermitte veroordeeld tot levenslang. Ze kwam in 2019 vrij en verbleef sindsdien in het psychiatrisch centrum Saint-Bernard in het Henegouwse Manage. Lhermitte stierf in het Leonardo da Vinci-ziekenhuis in Montigny-le-Tilleul. Ze vroeg en kreeg euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden.

Wat moet u weten om mee te praten? Ontvang elke middag nieuws en inzicht.

Op 28 februari 2007 doodde Lhermitte haar vijf kinderen in de gezinswoning in Nijvel. Haar man, Bouchaïb Moqadem, was op reis in het buitenland. Eerst verdoofde ze de kinderen, daarna sneed ze hun keel door. De jongste, Mehdi, was drie. De oudste, Yasmine, veertien.

Bron: DeMorgen

De euthanasie van terreurslachtoffer Shanti De Corte: ‘Op Instagram schreef ze dat ze dood wilde. Als moeder is dat vreselijk om te lezen’

juli 2023

Het grote assisenproces rond de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 loopt op zijn einde. Afgesloten van de rest van de wereld zit de jury de volgende weken samen om te oordelen over de schuld van Salah Abdeslam, Mohamed Abrini en co. Een van de 36 dodelijke slachtoffers is Shanti De Corte. Het meisje was 17 toen ze de aanslagen overleefde, maar koos in 2022 voor euthanasie. Fysieke verwondingen had ze niet, maar de jonge vrouw was murw geslagen door paniekaanvallen, depressies en flashbacks. Haar moeder doet het relaas van zes moeizame jaren. ‘Shanti voelde zich na de aanslagen nooit meer veilig.’



In 2021 schreef Shanti De Corte op haar Facebookpagina: ‘22 maart 2016. Je hebt me gebroken. Ik probeer te leven, echt waar, maar het waren vijf zware, intense jaren. Vijf jaar van gruwel, angst, verdriet, ongeloof, pijn, woede. Nu is het nog vallen, en daarna opstaan. Maar het wordt vallen en vallen en blijven vallen.’

In haar ouderlijk huis in Kontich is Shanti nog overal aanwezig. Foto’s van een vrolijk lachend meisje, schijnbaar zorgeloos, staan tussen kaarten die vrienden en klasgenoten na haar dood hebben opgestuurd. In een doosje ligt een halsketting met een beetje as van Shanti in een hanger. Die doet haar broer iedere dag om als hij naar school gaat. Ook in de armband van moeder Marielle De Ridder zit as van Shanti. Af en toe wrijft ze er tijdens het interview onbewust over.

Shanti De Corte werd vorige maand het 33ste slachtoffer van de aanslagen. De procureur vroeg de herkwalificatie van de beschuldiging van moordpoging naar moord voor haar en drie andere slachtoffers, die net als zij jaren later aan de gevolgen van de terreuraanslagen zijn gestorven. Een belangrijke stap, vindt Shanti’s moeder.

Twee van de vier ‘nieuwe’ slachtoffers zijn immers aan hun mentale worstelingen bezweken. ‘Vóór het proces ging de aandacht vooral naar de dodelijke slachtoffers van de aanslagen, en de slachtoffers met fysieke letsels. De zware mentale last die sommigen meedroegen, werd vaak vergeten. Dat is nu rechtgezet.’

Advocate Sanne De Clerck, die optreedt voor de slachtofferorganisatie V-Europe en ook Shanti’s zaak pleit, treedt haar bij. ‘Shanti stierf niet op de luchthaven, ze doofde uit over een periode van zes jaar.’

Hoe zwaar die mentale last op Shanti woog, begreep haar moeder pas toen ze, tijdens het proces, een psychologe van het leger hoorde uitleggen wat posttraumatische stress precies is.

Marielle De Ridder: "Slachtoffers van posttraumatische stress herbeleven keer op keer de gewelddaad, zei de psychologe. Ze durven niet meer te gaan slapen, ze zijn bang voor de nachtmerries. Het leek wel alsof ze Shanti beschreef."

Sanne De Clerck: "Je stuurde toen een sms naar mij: 'Dit is zo herkenbaar, ik begrijp Shanti nu veel beter.'"

De Ridder: "Andere slachtoffers met posttraumatische stress vertelden hoe ze het openbaar vervoer niet meer durven te gebruiken. Hoe zelfs gewoon naar buiten gaan al een overwinning was. Ook Shanti voelde zich na de aanslagen nooit meer veilig."

Shanti stond op 22 maart 2016 in de vertrekhal van Zaventem, klaar om naar Rome te vertrekken met haar klasgenoten van het zesde middelbaar.

De Ridder: "Ik heb haar die ochtend rond zeven uur afgezet aan haar school, het Sint-Ritacollege in Kontich. Ze nam kort afscheid: 'Oké, dag mama!' Even later stond ze al bij haar vriendinnen. De school had bussen gehuurd om de leerlingen naar de luchthaven te brengen. Ik was onderweg naar mijn werk toen ik Peter Van de Veire op de radio hoorde zeggen dat er een explosie had plaatsgevonden in Zaventem. Het was acht uur. Wat er precies gebeurd was, wisten we nog niet. Maar het bericht bleef de volgende minuten wel door mijn hoofd malen. Alles zal wel oké zijn, dacht ik, maar toen belde Shanti me op. 'Mama, er zijn hier twee bommen ontploft', riep ze in de telefoon. 'Wij zijn oké. Kun jij papa iets laten weten?' Daarna hing ze op. Ik reed op de ring rond Antwerpen en twijfelde: moest ik terug naar huis? En wat kon ik daar doen? Ik belde naar Peter, mijn partner, en naar de vader van Shanti. Pas toen ik op het werk de beelden van Zaventem zag, drong de ernst tot mij door. Ik ben naar haar school gereden, waar de leerlingen intussen al waren aangekomen. Ik wilde Shanti mee naar huis nemen, maar zij wilde blijven. Ik denk dat ze zelf nog niet goed wist hoe ze moest omgaan met wat er was gebeurd, en dat ze liever bij mensen wilde zijn die hetzelfde hadden meegemaakt."

Wat had Shanti meegemaakt op de luchthaven?

De Ridder: "Ze sprak er niet veel over. Wat ik weet, heb ik uit de schriftjes die ze met haar ervaringen vulde. Ooit wilde ze een boek schrijven, zei ze. Uit haar teksten bleek dat ze heel dicht bij de explosies stond. Shanti had net haar koffer ingecheckt en praatte wat met vriendinnen toen er plots een luide knal klonk. Iedereen bleef stokstijf staan. Shanti vroeg zich af of er misschien een loodzware koffer op de grond was gevallen. Maar toen volgde een tweede knal, met een lichtflits. Stukken plafond stortten achter haar naar beneden. Ze besefte dat er een aanslag werd gepleegd en begon te rennen. Dat heeft ze zichzelf later kwalijk genomen: dat ze meteen is weggelopen, en niet eerst heeft gekeken of ze hulp kon bieden. Ze rende met de anderen mee naar buiten en stond plots op het tarmac met haar klasgenoten en leerkrachten. Ze moesten naar het station van Zaventem lopen, maar toen ook in het metrostation Maalbeek een bom ontplofte, werden stations als gevaarlijk bestempeld en verzamelden de leerlingen in het centrum van Zaventem, waar de bussen hen oppikten."

Velen zaten die dagen aan het scherm gekluisterd om geen enkel detail te missen. Jullie ook?

De Ridder: "Neen, en zeker Shanti niet. Ze wilde niet naar het nieuws kijken. Die eerste week leek alles nochtans goed te gaan. Ze werd opgevangen op school, ze ging pizza eten met vriendinnen. Ze vroeg zich zelfs af of die reis naar Rome misschien toch kon doorgaan. Waanzin, als je er nu over nadenkt.

"Maar na verloop van tijd zag ik hoe Shanti zich begon af te zonderen. Ze kwam niet meer buiten, behalve om naar school te gaan. Naar de winkel durfde ze niet meer, daar liepen te veel onbekenden rond. In de trein of de tram: idem. Op weg naar school keek ze voortdurend rond: zijn er verdachte personen met een rugzak, dreigt er gevaar? Tegen lawaai kon ze ook niet meer. Ze kromp ineen als een ziekenwagen met een luide sirene voorbijraasde. Toen we hier op een keer een verjaardagsfeest vierden,

ontplofte een ballon. Shanti begon te hyperventileren. Later zei ze dat ze wel wist dat het maar een ballon was, maar dat ze geen controle had over haar reactie.

"Die zomer gingen we op vakantie naar Frankrijk. Daar zag ik voor het eerst hoe Shanti een paniekaanval kreeg. Ik weet niet meer wat de trigger was, maar ze lag op de grond, bevend van angst. Ze herbeleefde het moment van de aanslag. Dat was heftig om te zien."

De Rome-reis was sowieso geen evidente onderneming voor Shanti. Ze leed toen al enkele jaren aan hyperventilatie.

De Ridder (*knikt):* "Shanti deed zelf vaak achteloos over haar aanvallen. Ze kreeg die vanaf haar 15de. 'Te hard gefietst', hijgde ze als ik zag dat ze buiten adem thuiskwam. Maar de school is hier maar een kilometer vandaan! Toen ze ook eens hyperventileerde tijdens een examen, zijn we naar een therapeut gestapt. Dat was geen groot succes. Ze zat er gewoon drie kwartier lang uit het raam te staren. Later las ik in een van haar schriften dat ze helemaal geen therapie wilde. 'Van de vier keer dat ik ben geweest, heb ik drie keer niets gezegd', schreef ze."

Waarom wilde ze geen therapie?

De Ridder: "Shanti hield graag controle over de dingen. Niet kunnen meedoen met de groep, dat leek haar vreselijk.

"Nu, ze deed het goed op school, had veel vriendinnen en was heel sociaal, dus grote zorgen maakten we ons niet. Tot de hyperventilatie erger werd, en een uitstap met de school een probleem werd. Er waren niet genoeg leerkrachten om haar te begeleiden. Ze wilde dolgraag naar Rome, maar lange tijd was niet duidelijk of ze wel kon gaan. Een leerkracht heeft zich toen geëngageerd om de reis samen met haar voor te bereiden: waar ze naartoe zouden gaan, wat ze zouden zien, wat ze moest meenemen. Dat hielp enorm. De dag voor het vertrek was ze er helemaal klaar voor. Er kon niets meer misgaan, drukten we haar op het hart."

Sprak ze na de aanslagen over hoe ze zich voelde?

De Ridder: "Neen. Shanti vertelde mij heel weinig. Ze sloot me vaak buiten, en dat deed wel pijn. Tijdens haar aanval in Frankrijk ben ik naast haar gaan zitten en wilde ik mijn hand op haar been leggen, om toch maar iets te doen, maar zij duwde die weg. Ik ben dan maar op het terras gaan zitten.

"Op Facebook schreef ze open over haar trauma's, maar dat bleef vrij oppervlakkig. Op Instagram waren haar getuigenissen veel diepgaander, maar daar had ik geen toegang toe. Mijn zus en de buurvrouw had ze wel als vriend geaccepteerd. Zij stuurden me soms screenshots en dan las ik dat Shanti dood wilde. Als moeder is dat natuurlijk vreselijk om te lezen."

Waarom sloot Shanti u buiten?

De Ridder: "Om mij te sparen, denk ik. Ze wilde niet dat ik zag hoe erg ze leed. Ze zei op een bepaald moment: 'Het is beter dat jij niet alles weet, mama, dat je niet weet hoe erg het gaat met mij.'"

Ze schreef op haar Instagram-account dat ze huilend ging slapen, omdat het nooit goed zou komen met haar. En dat ze huilend wakker werd, teleurgesteld omdat ze nog leefde.

De Ridder: "De eerste keer dat we hoorden dat Shanti niet meer wilde leven, was in september 2016. Ze had zelf, zonder dat wij het wisten, een afspraak gemaakt bij een psychiater. Die belde mij om te zeggen dat hij Shanti onmiddellijk wilde laten opnemen in de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Daar is ze drie maanden gebleven. Daar heeft ze ook een eerste zelfmoordpoging ondernomen. Toen beseften we hoe diep ze zat. Ze leed aan tinnitus, had posttraumatische stress en een depressie. Ze kampte met een erg negatief zelfbeeld. Ze vond zichzelf niets waard. Ze zei soms: 'Ik kan beter doodgaan, want mijn leven heeft geen nut.' Op veel foto's staat ze lachend, maar thuis lachte ze zelden. Ze kwam thuis van school, ging naar haar kamer of lag in de zetel om wat te slapen of naar muziek te luisteren. Dat was alles wat ze deed. Ze had geen energie meer. Ze heeft maandenlang in een rolstoel gezeten, omdat ze niet alleen mentaal, maar ook fysiek helemaal op was."

Ze heeft nog een hogere studie gevolgd. Kon ze het studentenleven aan?

De Ridder: "Ze wilde leerkracht worden. Dat was echt iets voor haar: ze was altijd snel klaar met haar eigen taken en ging dan anderen uitleg geven. Twee dagen voor ze werd opgenomen in de psychiatrie, hadden we haar ingeschreven voor de opleiding van leerkracht lager onderwijs. Maar dat schooljaar viel in het water, omdat ze verschillende keren naar het ziekenhuis moest gaan. Toen Shanti het jaar daarna aan de opleiding begon, bleek al snel dat ze niet mocht deelnemen aan de kijkstages. De school was op de hoogte van haar situatie en was bang dat ze in de klas een paniekaanval zou krijgen. 'Dan zouden de kinderen hetzelfde trauma als Shanti kunnen oplopen', klonk het. Voor haar was dat een nieuwe klap, en ze is toen weer opgenomen. Later is ze overgeschakeld op de studie orthopedagogie, maar toen was al duidelijk dat studeren moeizaam ging. Ze kon zich niet concentreren in een aula met veel studenten. Ze durfde ook niet met de fiets naar de les. We hebben haar het eerste semester elke dag met de auto gebracht en opgehaald."

Later ging ze op kot.

De Ridder: "Dat was eigenlijk niet nodig, de school is maar 10 kilometer van hier. Ik gaf toe, omdat ik dan wat meer tijd zou krijgen voor mijn andere kinderen. Maar ook op kot ging het niet. Ze belde me geregeld met de vraag of ik haar niet kon komen halen, omdat ze weer een aanval had gehad.

"De volgende twee jaar verliepen met kleine pieken en diepe dalen. Ze studeerde, zat op kot, er was soms een crisisopname, er waren zelfmoordpogingen. Ze slikte zware medicatie, antidepressiva en slaapmiddelen. Ze nam Temesta om te kalmeren en de spanningen weg te nemen. Er waren periodes dat ze heel suf rondliep.

"Het liep pas echt mis toen een vriendin van haar uit het leven stapte. Dat was een mokerslag. Op een dag kreeg ik telefoon: Shanti lag in het ziekenhuis, omdat ze van het dak had willen springen. In het ziekenhuis zei ze: 'Mama, ik wil gewoon dood, kunnen ze mij niet laten doodgaan?' Tijdens een latere opname heb ik tegen de psycholoog gezegd dat hij tegen Shanti mocht zeggen dat ik openstond voor euthanasie, als ze het onderwerp ooit ter sprake zou brengen. Na nog eens een opname sprak Shanti mij er zelf over aan. Ze wilde weten hoe euthanasie gebeurt, en hoe je een aanvraag moest indienen. Ik heb haar gezegd dat ik haar zou steunen, maar dat ze zelf alle afspraken moest maken."

U vertelt het zo nuchter. Hoopte u niet dat ze haar plan zou opbergen?

De Ridder: "Neen, er was geen andere keuze. Natuurlijk wilde ik haar niet kwijt, maar ik zag geen oplossing. Mijn dochter leed pijn, ik voelde mij machteloos. Als ik als gezonde persoon al tegen mijn grenzen botste, hoe moest het dan voor Shanti zijn? Al die medicijnen, al die opnames en therapieën: ze hielpen niet. Al die zelfmoordpogingen: ooit zou er wel eentje lukken. En dan was ik haar kwijt, zonder dat ik afscheid had kunnen nemen."

Haar aanvraag voor euthanasie wegens ondraaglijk lijden werd goedgekeurd.

De Ridder: "Ze wilde sterven op 20 maart 2022, ze wilde niet nog eens een herdenking van de aanslagen meemaken. We bereidden alles zorgvuldig voor. Begin maart trok Shanti met haar vader enkele dagen naar zee. Op 16 maart stuurde ze mij haar lijst voor haar begrafenis: de muziek, de foto's, de teksten. Maar toen belde de dokter die de euthanasie zou uitvoeren. 'Er is een probleem', zei hij. De euthanasie kon niet doorgaan. Shanti was zo overstuur dat we haar naar de crisisopvang moesten brengen. De volgende dag vertelde de politie dat iemand een anonieme klacht had ingediend tegen Shanti's euthanasie. We konden een nieuwe datum vastleggen, maar pas zeven weken later."

Weet u intussen wie de klacht heeft ingediend?

De Ridder: "Ik heb mijn vermoedens. Maar als die persoon denkt dat hij ons met zijn klacht extra tijd heeft gegeven met Shanti, dan vergist hij zich. Hij heeft de pijn van mijn dochter onnodig gerekt. Die zeven weken waren een hel. Shanti verbleef vijf weken op de psychiatrische afdeling. Toen ze thuis was, moesten we opnieuw aan de voorbereidingen beginnen. Maar deze keer was er de stress van de onzekerheid. We vreesden voor een nieuwe klacht. Daarom gebeurde het afscheid in een veel kleiner

gezelschap. Shanti was tot op het laatste moment gespannen. Ze vertrouwde het niet helemaal. We hebben één voor één afscheid genomen van haar, ik zat als laatste een tijdje met haar hand in mijn hand, zonder veel te zeggen. Maar het is anders gelopen dan Shanti had gewild, en dat is jammer."

Shanti had zich in 2016 burgerlijke partij gesteld. Keek zij uit naar het assisenproces?

De Ridder: "Niet echt, ik denk dat ze zich burgerlijke partij had gesteld in de hoop haar angsten te kunnen verwerken. Ze is in oktober 2017 zelfs naar de beelden van de veiligheidscamera's in Zaventem gaan kijken. Dat heeft ze wel aangedurfd. Ze schreef daarna dat de terroristen verloren hadden, dat zij zich niet gewonnen zou geven. *(Stilte)* Toen nog wel. Later schreef ze: 'Ik heb de strijd verloren.'"

Na meer dan acht maanden nadert het einde van het proces, nu de jury zich heeft teruggetrokken. Hoe kijken jullie terug op die periode?

De Ridder: "Ik ben niet vaak naar de zittingen geweest. In het begin omdat ik wist dat Shanti ook niet zou zijn gegaan. Ze zou het niet aangekund hebben om opnieuw geconfronteerd te worden met wat er die dag is gebeurd. Misschien moet ik het ook loslaten, dacht ik. Maar dat kon ik niet. Af en toe volgde ik de zittingen via de webradio die justitie voor de slachtoffers had opgezet. Later ben ik twee keer naar een zitting geweest, om de pleidooien van de burgerlijke partijen te horen en naar de andere slachtoffers te luisteren."

De Clerck: "De solidariteit tussen de slachtoffers was erg opvallend. V-Europe vertegenwoordigt 150 van de meer dan 800 burgerlijke partijen. Niet iedereen kon het aan om te getuigen, maar ze kwamen wel, zoals Marielle, om de anderen een hart onder de riem te steken. Het proces duurt nu al meer dan acht maanden. Voor de slachtoffers is het niet vanzelfsprekend om vaak aanwezig te zijn, zeker niet als ze een job hebben. Wie kan acht maanden vakantie nemen?

"Emotioneel was het ook heftig. De speurders en hulpverleners die vertelden wat ze aantroffen op de plaats delict, de beelden die op oorlogstaferelen leken... Zelfs voor doorgewinterde professionelen was dat schokkend. Maar voor wie een kind of een partner heeft verloren, moet dat ronduit verschrikkelijk zijn geweest. Gelukkig was de ondersteuning voor de slachtoffers uitstekend."

De Ridder: "Ik wil nog een keer een zitting meemaken, gewoon om er te zijn. Misschien omdat ik vrees dat als het allemaal voorbij is, ik ook een stukje van Shanti kwijtraak. Ik blijf aan haar denken."

De Clerck: "Voor jou is het ook nog maar een jaar geleden. De meeste nabestaanden hebben iemand op de dag zelf verloren. Zij hebben meer tijd gehad om alles te verwerken."

Mevrouw De Ridder, u hebt de beschuldigden gezien op het proces. Een van hen, Mohamed Abrini, de man met het hoedje, zag op het laatste ogenblijk af van het plan om zich op te blazen in Zaventem.

De Ridder: "Die daders lieten mij onverschillig. Dat klinkt hard, ik weet het. Maar de enige keren dat ik iets voelde toen ik hen zag, was toen ze tijdens een van de pleidooien met elkaar aan het babbelen en het lachen waren. Dat vond ik ongepast."

De jury moet nu over de schuldvraag beslissen. Is er nog iemand die twijfelt aan de uitkomst?

De Clerck: "Voor ons is alles duidelijk: het onderzoek is minutieus gevoerd en toont de schuld van de beschuldigden duidelijk aan. Al is het natuurlijk aan de jury om daarover te oordelen. Verschillende beschuldigden, zoals Salah Abdeslam en Sofiane Ayari, zaten in de gevangenis ten tijde van de aanslagen in Brussel en vragen daarom de vrijspraak."

Tijdens het proces van de aanslagen in Parijs, waar de meeste beschuldigden van het huidige proces al werden veroordeeld, gaven sommigen toe dat ze in de fout waren gegaan. Er volgden zelfs excuses. Ziet u dat hier ook gebeuren?

De Clerck: "Voorlopig is dat nog niet gebeurd. De beschuldigden krijgen na deze procesweek nog de mogelijkheid tot een laatste woord *(dit interview werd voordien afgenomen, red.)*. Misschien horen we

dan wel spijtbetuigingen, wie weet. Tot nu toe heeft enkel Mohamed Abrini rechtstreeks het woord gericht tot de slachtoffers. Dat gebeurde na de getuigenis van een koppel waarvan de vrouw zwaargewond was geraakt. Ze ging ook erg gebukt onder posttraumatische stress. Haar man stond erop dat hij mocht getuigen, want ook zijn leven was helemaal overhoopgehaald. Man en vrouw kwamen hand in hand de rechtszaal binnen. Je zag hoe erg ze aan elkaar verknocht waren. De man vertelde dat ze vroeger vaak op reis gingen, maar dat hun wereld na de aanslagen heel klein was geworden. De vrouw zei dat ze zich twee jaar lang meer dood dan levend had gevoeld. Daarna stond Abrini plots op. Hij bedankte het koppel voor hun getuigenis en zei dat het hem speet dat ze die beproeving hadden moeten doorstaan. Dat was het enige moment dat er zo'n vorm van interactie was tussen de burgerlijke partijen en de beschuldigden."

Zou u met de beschuldigden willen praten, mevrouw De Ridder?

De Ridder *(kort):* "Neen. Voor mij zijn die beschuldigden zielige mensen die mijn energie niet waard zijn."

Na de schuldvraag moet de jury ook nog de strafmaat bepalen. Daarna volgen de procedures voor de schadevergoedingen.

De Clerck: "Dat is voor na de zomervakantie. De schadevergoeding bepalen voor alle slachtoffers en nabestaanden wordt ook nog een belangrijke taak."

Na het Reuzegom-proces was er verontwaardiging omdat de vader van Sanda Dia maar 15.000 euro schadevergoeding kreeg voor de dood van zijn zoon.

De Clerck: "Die schadevergoedingen liggen vast. Voor de dood van een kind is dat inderdaad maar 15.000 euro. Dat is heel weinig in vergelijking met andere landen. Bovendien liggen schadevergoedingen voor levende slachtoffers veel hoger. Als je iemand doodrijdt bij een verkeersongeval, moet je dus minder betalen dan wanneer het slachtoffer het overleeft en in een rolstoel terechtkomt."

Had u ooit gedacht dat u op een dag zo'n berekening zou moeten maken voor Shanti?

De Ridder: "We zijn ooit bij een verzekeringsarts geweest om te bepalen welke schadevergoeding ze kon vragen. *(Stilte)* Maar toen leefde Shanti nog en was er hoop op beterschap. Het is inderdaad schrijnend dat er zo'n kleine som staat tegenover zo'n groot verlies. Maar eigenlijk heeft al dat rekenwerk geen belang voor mij: geen enkel bedrag brengt Shanti terug."

© Humo

Interview Wout Van Steenwinkel

Zes jaar nadat moeder van Wout (25) verkracht werd, mag ze euthanasie plegen: 'In dit verhaal is er maar één schuldige'



Wout Van Steenwinkel uit Vilvoorde vertelt over het goedgekeurde euthanasieverzoek van zijn mama. Beeld Marc Baert

‘Wil ik het weten als ze een datum voor de euthanasie heeft gekozen? Wil ik erbij zijn?’: het zijn vragen waar Wout Van Steenwinkel (25) uit Vilvoorde een antwoord op moet vinden nu de euthanasieaanvraag van zijn mama Nathalie werd goedgekeurd. In september 2016 werd Nathalie Huygens (50) tijdens het joggen in Vilvoorde op een brutale manier verkracht en voor dood achtergelaten. Na meer dan zes jaar strijden, weegt het psychisch lijden te zwaar door. En zo komt het levenseinde van Nathalie wel heel dichtbij. Ook voor haar kinderen. ‘Als mensen zeggen dat mama haar kinderen in de steek laat, word ik kwaad. Niemand weet wat het is om in haar schoenen te staan.’

CARMEN SCHELKENS 16 januari 2023, DeMorgen

Meer dan zes jaar nadat zijn mama Nathalie op gruwelijke wijze verkracht werd, is Wout stilaan aan zijn eigen verwerkingsproces begonnen. Het keerpunt was de open brief die hij in maart 2022 schreef en waarin hij onder meer oproept tot juridische hervormingen en een betere opvang voor de slachtoffers. Er bestaat geen twijfel over dat een traumatische ervaring niet alleen een gigantische impact heeft op het slachtoffer, maar ook zijn of haar omgeving. De kans bestaat dat Wout straks door het leven zal moeten gaan zonder zijn mama, die onlangs groen licht kreeg voor euthanasie wegens psychisch lijden. Een open en eerlijk relaas over hoe het is om als kind aan de zijlijn te staan, maar er tegelijk toch middenin te zitten.

Blijf op de hoogte

Krijg een melding bij belangrijke artikelen over In het nieuws.

Jouw open brief had een enorme impact op de samenleving. Wat gebeurde er in de nasleep van je woorden?

"Na de brief kreeg ik veel steun van mensen die in dezelfde situatie zitten of zaten. Dat deed enorm deugd. Ik had alleen maar durven dromen dat mijn woorden zo'n impact zou hebben. Maar nu de euthanasie-aanvraag van mama is goedgekeurd, komt er ook negatieve commentaar."

Hoe reageren mensen dan op de goedkeuring van de euthanasie-aanvraag?

"Mensen begrijpen de keuze van mama niet. Sommigen vinden het egoïstisch naar ons, haar kinderen, toe. Maar zo zwart-wit is het niet. Langs de ene kant begrijp ik waarom mijn mama de euthanasie-aanvraag heeft gedaan, en steun ik haar daar ook in. Als zoon is mijn grootste wens diep vanbinnen natuurlijk dat mijn mama nog jaren leeft en mij verder ziet opgroeien, maar dan neemt mijn rationele kant het over. Ik besef dat het voor mij en mijn zus moeilijk is, maar ik kan mij alleen maar inbeelden dat de hel waar mijn moeder door moet, zeker tien keer zo verschrikkelijk is. Wie ben ik dan om mee te beslissen over haar levenseinde? Dat recht heb ik niet. Natuurlijk had ik het liever anders gewild. Maar mijn mama als verantwoordelijke aanduiden, dat kan ik niet. In dit verhaal is er maar één schuldige die haar tot deze beslissing dreef: de man die haar verkracht heeft. Ik weet dat ze alles heeft geprobeerd. Vanuit mijn eigen positie probeer ik in te schatten hoe het voor mijn mama moet voelen, maar ik zal nooit weten hoe het is voor haar. Daarom vind ik niet dat ik het recht heb om haar beslissing af te keuren. Ik zou niet willen dat ze alleen voor mijn zus en ik blijft leven. Dat wil ik haar niet aandoen. Daarom hebben we als familie ook beslist om geen protest aan te tekenen tegen de beslissing. Maar ik weet dat het heel hard zal zijn wanneer ze er niet meer zal zijn, harder dan het de voorbije jaren ooit geweest is. Dat het gemis nooit zal weggaan, dat weet ik nu al."

Kan je begrijpen dat mensen vinden dat je mama haar kinderen achterlaat? Heerst er nog een groot taboe op euthanasie omwille van psychisch lijden?

"Ik kan er ergens inkomen dat mensen het moeilijk vinden om te begrijpen dat ze kiest voor euthanasie. Een einde maken aan je leven omwille van fysiek lijden is al ingeburgerd in ons land, maar er heerst nog steeds een taboe rond euthanasie omwille van psychisch lijden. Mensen weten ook niet goed hoe ze met een slachtoffer moeten omgaan. Een oordeel vellen over een slachtoffer is snel gedaan, maar het is niet altijd gemakkelijk om te begrijpen waar die persoon in kwestie doorgaat."

Nathalie Huygens en haar zoon Wout Van Steenwinkel

Waar sta jij in je verwerkingsproces?

"In het begin heb ik het heel erg afgeblokt om concreet na te denken over die euthanasie. Maar dankzij mijn open brief kwam ik in contact met praatgroep PUNT.vzw, waar ik nu maandelijks naartoe ga. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik meer ben gaan stilstaan bij wat er is gebeurd. Bijna zeven jaar lang probeerde ik te vluchten door zo veel mogelijk afleiding te zoeken. Reizen, me op mijn studies storten, … Alles deed ik eraan om zo min mogelijk te denken aan wat er gebeurd was. Maar nu begin ik beetje bij beetje alles te verwerken. De afgelopen maanden zijn daardoor eigenlijk de moeilijkste tot nu toe geweest. Vooral een gevoel van machteloosheid en onrechtvaardigheid kwam naar boven. Stilaan besefte ik hoe hallucinant het is dat een mama, die voordien zoveel levensvreugde had en me waarden had meegegeven, nu bezig is met haar levenseinde. Ik ben ook beginnen nadenken over hoe het moment van de euthanasie zou verlopen. Maar het blijft allemaal onzeker."

De aanvraag is goedgekeurd, maar hoe concreet zijn de euthanasieplannen nu?

"Dat weten we zelf niet. Het is niet omdat je groen licht krijgt voor euthanasie, dat je effectief moet verder gaan met de procedure. Sowieso is het een proces dat niet over één nacht ijs gaat en waar tientallen gesprekken aan vooraf zijn gegaan. Dat was ook zo bij mama, die deze beslissing weloverwogen heeft genomen. Misschien is de goedkeuring voor haar nu wel voldoende om te weten dat ze een uitweg heeft als ze dat wil. Het kan zijn dat ze nog jaren zal blijven leven. Ergens zou dat wel fijn zijn als de goedkeuring haar voldoende kracht geeft om toch verder te gaan. Een datum is er nog niet nu ze groen licht heeft gekregen. Gaat ze ons volgende week meedelen dat het binnenkort zover is? We

weten het niet. Het enige dat zeker is, is dat ze wil wachten op haar burgerlijk proces. Dat vindt ze naar ons, haar kinderen toe, heel belangrijk. Maar we wachten ondertussen al zes jaar op dat proces, een datum is er nog steeds niet. Gelukkig kan ik met al mijn vragen wel bij mama terecht, ook al doe ik dat niet altijd. Mijn zus en ik zijn ook al samen met een dokter gaan praten over de euthanasie. Het gesprek stond in het teken van wat wij wensen als kinderen. Willen we erbij zijn? Willen we het weten als ze een datum heeft gekozen? Het zijn praktische vragen, maar het is fijn dat er zo'n omkadering is."

Heb je al voor jezelf kunnen uitmaken wat het antwoord is op al die vragen?

"Eigenlijk wel. Ik wil er graag bij zijn wanneer ze euthanasie pleegt. Anders zou ik er toch mee bezig zijn, waar ik ook zou zijn op dat moment. Ik zou de hele tijd naar de klok kijken, wetende wat er een aantal kilometer verderop gebeurt. Dat lijkt me heel raar. Het lijkt me fijn voor haar als ze tijdens haar laatste momenten omgeven wordt door mensen die ze lief heeft en haar kunnen geruststellen."

(Lees verder onder de foto)



Nathalie Huygens in de reportage die haar zoon Wout (25) maakte. Beeld YouTube/ Wout Van Steenwinkel

Is dat ook wat zij wil?

"Ze zou het moeilijk vinden om ons erbij te hebben omdat ze dan het verdriet op onze gezichten zou kunnen aflezen. Natuurlijk is dat onvermijdelijk op zo'n moment. Maar ze respecteert wel onze wens om erbij te zijn."

Hoe is de band nu met je mama?

"We zijn twee handen op één buik. Het is één van de belangrijkste mensen in mijn leven. Dat maakt het net moeilijk om haar nu te zien en te gaan opzoeken. Ze doet heel erg haar best om niets van haar problemen te laten merken. Omdat ze ons wil sparen en het gevoel heeft dat ze mijn zus en mij hier mee in heeft gesleurd. Maar wij doorprikken dat. Op het kerstfeest was dat bijvoorbeeld heel duidelijk. We zagen dat ze het moeilijk had. Een deel van de mama hoe ik haar kende van voor de feiten, is nu weg. Het beeld van mijn mama als een optimistische en vechtlustige vrouw is er nog zeker en heeft ervoor gezorgd dat ze het al zeven jaar lang dapper heeft volgehouden. Maar nu begint het te zwaar door te wegen en ziet ze geen uitweg meer. En dat is heel pijnlijk om te zien. Daarom vermijd ik soms om bij haar langs te gaan. En dat zal ontploffen in mijn gezicht op de dag dat ze euthanasie pleegt. Dan zal ik

me afvragen waarom ik er niet vaker was voor haar. Dat knaagt enorm hard aan mij. Maar het is soms te confronterend om haar te zien. Dat wil echter niet zeggen dat als je haar op straat tegenkomt, het van haar gezicht af te lezen valt. Dat is ook misschien ineens een grote misvatting over slachtofferschap. Je kan het zwaar hebben, maar dat wil niet zeggen dat je steeds droevig in een hoekje zal zitten."

Heb je lang hoop gekoesterd dat je mama weer de oude zal worden?

"Zeker. Toen ik het nieuws over de verkrachting vernam, dacht ik 'dit is het moeilijkste moment, vanaf nu zal het alleen nog maar beter gaan.' Een paar dagen later toen ik thuiskwam en haar voor de eerste keer zag, ging dezelfde gedachte nogmaals door me heen. Heel lang had ik het idee dat alles goed zou komen. Maar er gaat een jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar voorbij met ups en downs. Om dan vast te stellen dat het eigenlijk nog minder goed gaat. En te beseffen dat alles niet plots zal opgelost geraken. Die klap is gigantisch. Maar gelukkig hebben we niet alleen maar ellende gekend, en zijn er nog veel mooie momenten samen. Ik heb er bewust voor gekozen om de gruwelijke feiten niet heel mijn leven te laten bepalen. De dader heeft ons al genoeg afgepakt. Ik weiger om ook nog mijn geluk van mij te laten afnemen. Dat gun ik hem niet."